EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69360
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-19 12:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELISA DEL CARMEN HERNANDEZ .			RUN	: 3.002.211-4
F.Nac	: 21-09-1925	Edad	: 97 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 16-08-2023	Fecha Egreso	: 2023-08-19 12:00:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico ínsulo-témporo-parietal derecho
-FA crónica sin TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
-Enf: HTA, ICC, ERC, portadora de marcapaso, ACV isquémico antiguo secuelado con hemiparesia BC derecha, deterioro cognitivo mayor, EAOC EEII, fibrosis pulmonar
-Fcos: FSD 40 mg/d, amiodarona (200 mg) 1/2 comp/d, metolazona 2.5 mg c/48h, bisoprolol (2.5 mg) 1/2 comp/d, febuxostat 40 mg/d, ATV (20 mg) 1/2 comp la día, omeprazol 20 mg c/48h, PGB 75 mg/d (aumentar a 75 mg c/8h según necesidad), ipratropio 2 puff c/6h, Brexotide 2 puff c/12h, acenocumarol según esquema poliTACO, lactulosa, metamizol 300 mg c/72h SOS, losartan?
-Qx: colecistectomía, HNP
-Alergia(-)
-OH(-) Tabaco(-) Drogas(-)
-Diestra
-mRS 5

Historia clínica
Paciente previamente en su basal, última vez vista en su basal a las 04 AM del 16/8/23, fue encontrada por hija (cuidadora) en su cama aprox a las 10 AM del mismo, se observa quejumbrosa, somnolienta, con dificultad marcada para emitir lenguaje o seguir órdenes, y hemiparesia BC izquierda. Es traslada a SU HSC, PA 100/60 FC 63 T 36.9 sat 98 amb.
TC cerebro s/c mostro tenue hipodensidad de aspecto agudo temporo-parietal derecha y lesion isquémica secuelar frontal izquierda. Exs de lab destaca crea 1.6 INR 1.52, K 2.9. Se hospitaliza para evaluación y manejo.

Evolución
Paciente en malas condiciones generales, HDN estable (sin uso de antihipertensivos) , eupneica, afebril, tolera bien alimentación por SNG, estable en su condición respecto al día de ayer.
ELP de control mostró hipokalemia corregida.
TC cerebro s/c de control del 17/8/23 muestra infarto establecido ínsulo-témporo-parietal derecho sin TH.
En vista de la baja funcionalidad basal, múltiples comorbilidades y severo compromiso neurológico actual, se decide posponer estudio con angioTC cerebro y cuello, ETT y Holter de ritmo hasta observar

mejoría clínica significativa; IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica, alta a domicilio el 19/8/23 y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días.
Diuresis(+) dep(+)

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 19/8/23
-Alimentación papilla por SNG
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días
-Mantener anticoagulación suspendida hasta control en policlínico

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/d
2. -Atorvastatina 40 mg/noche
3. -Omeprazol 20 mg/d
4. -Bisoprolol (2.5 mg) 1/2 comp/d
5. -Ipratropio 2 puff c/6h
6. -Brexotide 2 puff c/12h
7. -PGB 75 mg sólo SOS en caso de dolor
8. -Metamizol 300 mg sólo SOS en caso de dolor
9. -Lactulosa 30 cc c/8h si constipación
10. -Metolazona (Pavedal) 2.5 mg SOS si edema EEII

EXÁMENES Y RESULTADOS

17/8/23
-Na 140 K 4 Cl 103

16/8/23
-Glic 125
-Crea 1.6 MDRD 29.76 Uremia 195
-FA 226 BI 0.72 BD 0.28 BT 1 GOT 64 GPT 43 GGT 120
-Lact 1.1
-PCR 7.6
-Na 135 K 2.9 Cl 92
-Hb 14.2 Leu 5500 Plaq 198000 Seg 80 VHS 43
-INR 1.52 TTPA 30

OBSERVACIONES:

Ex fco general
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RII, 2T, no ausculto soplos por ruidos pulmonares
-Pulmonar: MP dismnuido bilateralmente, crepitos ++/++ difusos mayor hacia las bases
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), hiperpigmentación distal EEII, úlcera cara lateral pierna derecha

Ex neurológico:
-Mental: somnolienta, muy quejumbrosa, no emite lenguaje ni sigue órdenes, resto n/e
-PC: CV n/e, pupilas medias e isocóricas, RFM +/+, reflejo corneal D/C +/+, ROC verticales y horizontales N,
nistagmo(-), úvula y lengua centrales, resto n/e
-Motor: ESI M0, EII M1-2, ESD M5, EID M2, RCP indiferente bilateral, localiza al dolor con ESD
-Sensitivo: algesia impresiona conservada
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO